

Fecha Última Actualización: 07-03-2022 21:22:39

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Andres Antonio Rodriguez Rodriguez
Edad : 64a 0m 2d
Dirección : Parque Portugal 1791

Rut : 7.849.680-0
Fecha Nacto: 05/03/1958
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 0611768
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 7214 6646

N° Epicrisis
294864

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 27/01/2022 22:31

Días Estadía: 39

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 07/03/2022 21:03

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Paro Cardiorespiratorio . Insuficiencia Hepática Aguda.

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Resumen de traslado

Nombre: Andrés Rodríguez Rodríguez
Edad: 63 años
RUT: 7849680-0
FI CASR: 27/01/22
FI UPC: 28/01/22

Antecedentes:

- Antec. Médicos: Vitíligo, ACV no secuelado (2000), valvulopatía mitral operada
- Medicamentos: TACO
- Antec. Qx: balonplastía mitral (2003)
- Alergias: (-)

Anamnesis próxima:

Paciente inicia el 20/01/22 con cuadro de tos irritativa. Sin rinorrea, odinofagia, mialgias u otros síntomas que sugieran cuadro viral alto.

El 24/01/ evoluciona con ictericia progresiva de piel y escleras asociado a dolor abdominal difuso, disnea progresiva, hasta hacerse de reposo y diarrea sin elementos patológicos.

El 25/01 se agrega a cuadro descrito, gingivorragia y epistaxis (esta última autolimitada).

Niega baja de peso, acolia o síntomas urinarios.

No tiene antecedente de consumo de paracetamol ni otro toxico.

Se sospecha hepatitis aguda con criterios del King College de trasplante hepático. Serología HepB y C negativas, VIH negativo.

Exámenes de ingreso destacó Hiperbilirrubinemia 24.7; predominio directo (18.3). FA 322; GGT 581; GOT 1700; GPT 1908; INR > 10; PCR: 93

Serología:

- Serología Hep B y Hep C negativas
- VIH negativo

Fecha Epicrisis : 07/03/2022 21:22

Página 1 de 3

- PCR COVID negativa

AngioTAC 28/01/22:

- Leve engrosamiento hipodenso de la pared vesicular, hallazgo que pudiese estar explicado por cambios edematosos en contexto de hepatopatía.
- Leve edema periportal.
- Pequeña adenopatía en relación al hilio hepático, probablemente reactiva.
- Múltiples pequeñas adenopatías y linfonodos prominentes retroperitoneales e ilíacos derechos asociado a leve engrosamiento del tejido adiposo adyacente hallazgo inespecífico, pudiesen estar en el contexto de cambios reactivos a patología inflamatoria
- Infecciosa abdominal versus síndrome linfoproliferativo.
- Ateromatosis aorta - biliar.

Paciente evoluciona con requerimiento de oxígeno suplementario, regular mecánica respiratoria. Ingres a UCI para control evolutivo dado sospecha de falla hepática fulminante.

Evolución en UCI:

Hemodinámico: No cursó con disfunción circulatoria. Tuvo caída de hematocrito de 10 puntos en su hospitalización, sin exteriorización de sangrado. Se mantuvo en observación con hematocrito estable. Además, evolucionó con FA RVR intermitente sin impacto hemodinámico. Se inició ayer control de frecuencia con Atenolol con regular respuesta. Hoy se deja digital SOS.

Ventilatorio: Sin mayor conflicto de intercambio. Ingresó con CNAF que se fue titulando hasta su suspensión el día de ayer. Hoy con naricera que se suspende durante la tarde dado registro de hiperoxemia. Actualmente FiO2 ambiental.

Infectológico: Ingresó con parámetros inflamatorios elevados y opacidades nodulares con densidad de vidrio esmerilado bilateral leves que progresaron en imagen de control. Se cultivó, CAET sin muestra suficiente, HC pendientes y UC resultó negativo. PCR COVID-19 (-). Se dejó en forma empírica AMS. Se ha mantenido afebril por el momento.

Gastroenterológico: Ingres a falla hepática aguda de causa aún no precisada. Clínicamente icterico y con hiperbilirrubinemia de predominio directo. Desde ingreso se instauró N Acetil Cisteína. Dentro del estudio se solicitó serología VHC y VHB negativo. VHA pendiente. Hoy se tomó estudio ampliado con serología para CMV, Chagas, Herpes, VEB, toxoplasma, HTLV y marcadores autoinmunes.

Ingresó con coagulopatía con INR > 10, que se corrigió con Vitamina K y PFC por lo que se asumió 2ario a TACO. Evoluciona con Hiperbilirrubinemia en lento ascenso pero transaminasas y FA a la baja. INR de hoy en 1.9. En seguimiento por equipo de Hepatología.

Renal e hidroelectrolítico: Cursó sin mayor conflicto. Se mantuvo con buena función y depuración. Sin alteración hidroelectrolítica relevante.

Paciente en condiciones de traslado a unidad de menor complejidad para continuar manejo y seguimiento.

Diagnósticos de Egreso:

- 1.Hepatitis Aguda
 - > Falla Hepática Aguda fulminante
 - > King College Criteria N on-Acetaminphen toxicity (+)
 - > Obs Hepatitis con alteracion del coagulograma por TACO
- 2.Adenopatías múltiples en estudio
- 3.Discoagulopatía: TACO vs Falla Hepática Aguda
- 4.Estenosis Mitral con Plastia
 - > Usuario de TACO (Acenocumarol)
- 5.ACIV no secuelado
6. FA debut

Diagnóstico de Egreso

Insuficiencia hepática aguda -

Fecha Epicrisis : 07/03/2022 21:22

Fecha Última Actualización: 07-03-2022 21:22:39

Página 3 de 3

Insuficiencia hepática aguda - Falla Orgánica Múltiple.

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J: NO

FALLECIDO

Plan Post Alta

FALLECIDO

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Carlos Alarcon Silva
Médico Tratante (Staff)